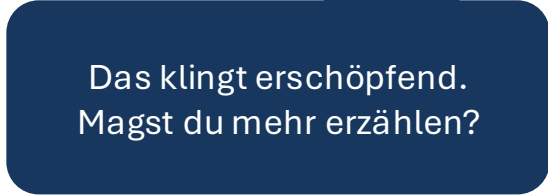


Hier gehts zu den Folien

An orange silhouette of a person's head and shoulders, positioned to the left of the first speech bubble.

Ich schäme mich,  
auch für längst Vergangenes.

A dark blue silhouette of a person's head and shoulders, positioned to the left of the second speech bubble.

Das klingt erschöpfend.  
Magst du mehr erzählen?



# „Schambot“: Entwicklung, Architektur und erste empirische Befunde

Laura Alex (M. Sc.) & Prof. Dr. Jakob Fink-Lamotte - Universität Potsdam - Deutscher Psychotherapie Kongress 2026

23.10.

Ich müsste für die Flexibilität mehr für mich erkämpfen, aber **die Kraft habe ich nicht**. Mich müssten wahrscheinlich sehr viele Menschen anschreiben, und mich auch sehr mit meiner **Behinderung** beschäftigen, aber eigentlich möchte ich einfach nur studieren.

Es fühlt sich also an, als ob deine Behinderung viel Raum einnimmt, obwohl du eigentlich „einfach nur“ studieren möchtest. Was denkst du, was genau dazwischensteht?

**Ich kann nicht mehr**, bin zu müde

---

24.10.

Ich möchte kompetent wirken...

Vielen Dank für deine Nachricht. Ich höre dir zu.

# Motivation: Warum Scham, Chatbots & Selbstmitgefühl?

## Scham als klinische Zielgröße

- Transdiagnostisch: Depression, Angst, sozialer Rückzug Kim et al. (2011)
- Hohe Vermeidungsdynamik → schwer zugänglich in Therapie Dearing & Tangney (2011)

## Chatbots als niedrigschwelliger Zugang

- Anonymität senkt Offenbarungsschwelle
- Alltagseinbettung → asynchron, ortsunabhängig Casu et al. (2024)

## Selbstmitgefühl als Intervention

- Protektiver Faktor gegenüber Schamerleben Fink-Lamott et al. (2023)

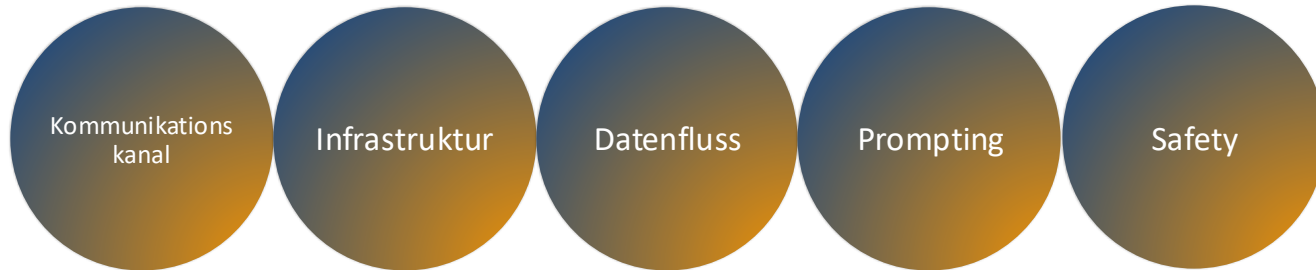
## Kernfrage dieses Vortrags

*„Wie baut man unter realen (universitären) Bedingungen einen DSGVO-konformen therapeutischen KI-Chatbot - und welche ethischen Zielkonflikte entstehen dabei?“*

→ Design- und Implementation-Case-Study

# How to Build Your Own Ethical Psychotherapy Chatbot

## Fünf Entscheidungsfelder – vom Konzept zur laufenden Studie



# Schritt 1 + 2: Kommunikationskanal & Infrastruktur

## 1. Kommunikationskanal wählen

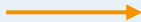
### Entscheidung: Signal Messenger

- Niedrigschwellig
- Open Source
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- Kein eigenes Frontend nötig



*Alternativen: WhatsApp (USA, Meta-Infrastruktur), Telegram (UAE), eigene Webapp*

*Open Source Alternative:  
Matrix/Element – siehe Poster #1726*



## 2. SaaS oder eigene Infrastruktur

### Uni-Server (ZIM Uni Potsdam)

- Kein kommerzieller Therapie-Chatbot
- Volle Kontrolle über Datenfluss
- Forschungsintegration möglich

*KI-Projekte sind institutionell eingebettet:  
Steuerung vor Technik*

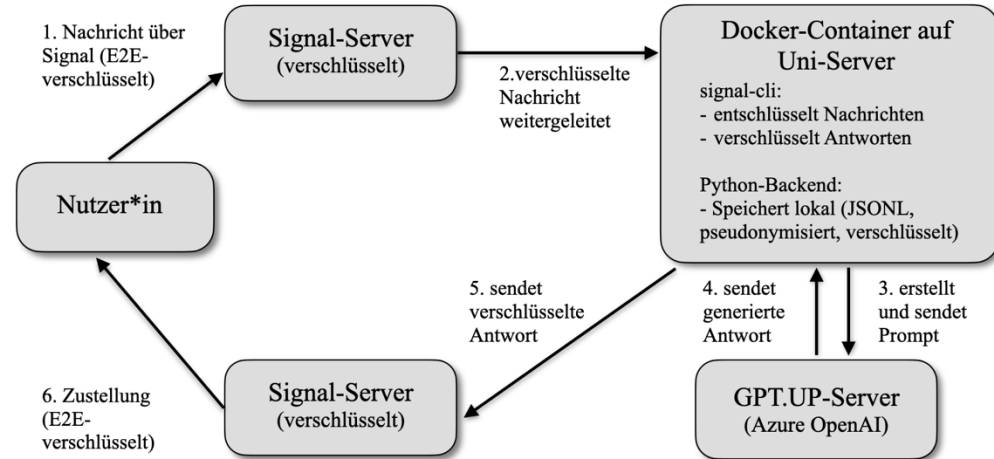
## Schritt 3: Datenfluss kontrollieren

### 3. Datenfluss kontrollieren

- Nutzer\*in → Signal → Backend → Azure OpenAI → Backend → Signal
- Kein direkter Kontakt Nutzer\*in ↔ GPT
- Telefonnummern verschlüsselt, lokale Speicherung
- Azure EU-Rechenzentren (DSGVO-konform)

#### Warum GPT?

- Bestes Modell zum Zeitpunkt der Studie
- Natürliches Spracherlebnis
- Via Azure DSGVO-konform



→ Aktuell: Umstieg auf EU-basierte Mistral-Modelle

# Schritt 4 - Therapeutisch prompten

## 4. Therapeutisches Verhalten prompten

### GPT ≠ autonom

- Verhalten = Ergebnis von Designentscheidungen
- Systemprompt: empathisch, validierend, nicht pathologisierend
- Woche 1: Exploration / Woche 2: Intervention

*Prompting = Therapiegestaltung*

```
response = client.chat.completions.create(  
    model=deployment,  
    messages=[  
        {"role": "system",  
         "content": "Du bist ein empathischer Therapeut mit 10 Jahren "  
                    "Praxis in Schamforschung. "  
                    "Antworte auf Deutsch, benutze die informelle Du-Form. "  
                    "Halte dich kurz und menschlich. "  
                    "WICHTIG: Sei authentisch, nicht kitschig."},  
        {"role": "user", "content": prompt}  
    ],  
    max_tokens=250,  
    temperature=temperature
```

# Schritt 5: Safety-Mechanismen implementieren

## Was wurde implementiert?

- Azure Content Filter (automatisch)
- Krisenprotokoll im Systemprompt
- Sessionlänge & zeitliche Begrenzung
- Weiterleitung an professionelle Hilfe

## Das zentrale Problem

### Azure-Filter blockiert Scham-Inhalte

(Schamberichte, selbstkritische Formulierungen, emotionale Intensität)

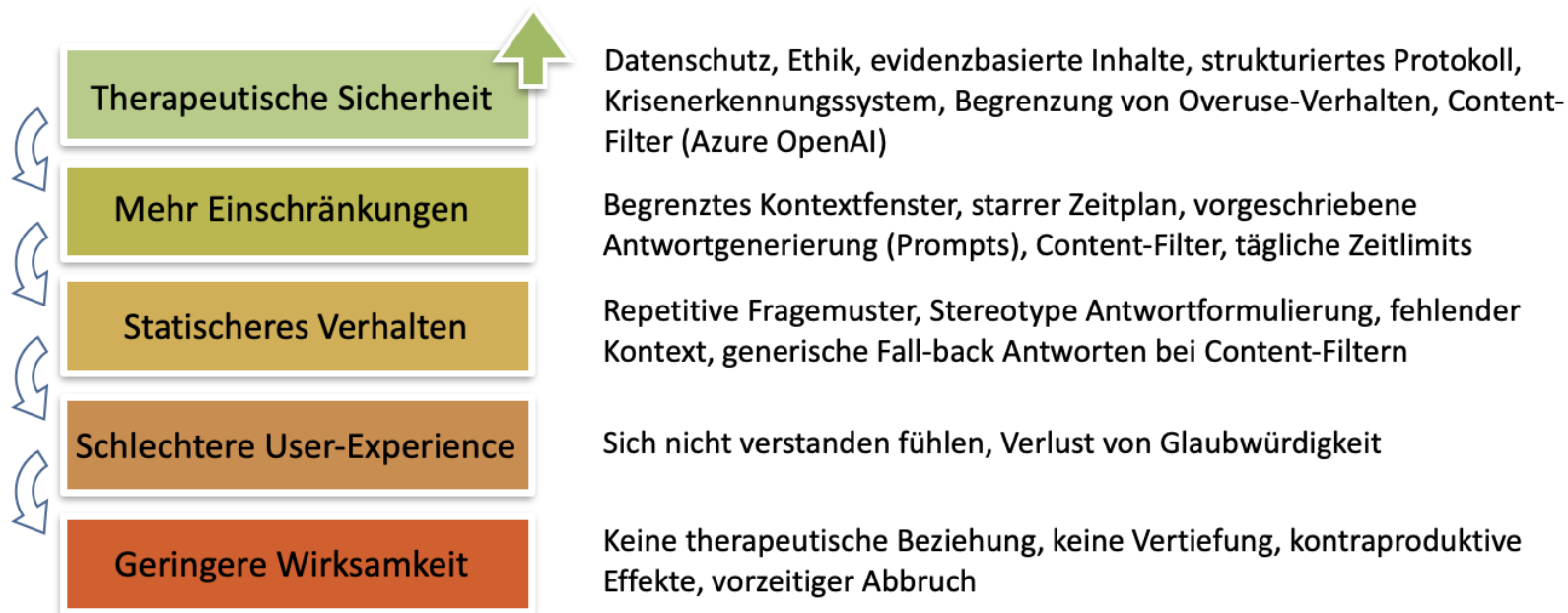
... genau diese Inhalte sind therapeutisch relevant

### *Sicherheit vs. therapeutische Authentizität*

*„Vielen Dank für deine Antwort. Ich höre dir zu.“*



# Das Sicherheits-Paradoxon



*Je mehr Sicherheit, desto geringer die therapeutische Wirksamkeit – und umgekehrt.*

# Studiendesign & Ergebnisse

*Alex, L., Fink-Lamotte, J. (2026). “KI in der Psychotherapeutischen Versorgung: Eine Chatbot-Intervention zur Selbstmitgefühlsförderung bei Scham“*

# Studiendesign & zentrale Befunde

## Design

**N = 92**

davon n = 51 vollständig abgeschlossen

- 2-Wochen-Intervention via Signal
- Woche 1: Schamerfassung (dialogisch)
- Woche 2: Selbstmitgefühl-Intervention
- Fragebogenerhebung T1, T2, T3

*Etablierte Maße für State/Trait-Scham & Selbstmitgefühl  
+ Einstellungen zu KI & Akzeptanz des Chatbots*

## Zentrale Befunde

- ✓ Chatbot DSGVO-konform realisierbar und nutzbar (Uni-Kontext)
- ✓ Konvergente Validität des Scham-Assessments:  $p \approx .820$
- ✓ Empathie positiv bewertet
- X 50,6 % negative Nutzungserlebnisse

# Take-Home Messages

1. DSGVO-konforme Chatbots sind realisierbar, auch unter universitären Bedingungen
2. Architektur bestimmt Ethik: jede Designentscheidung hat Konsequenzen
3. Prompting = Therapiegestaltung
4. Sicherheit vs. Wirksamkeit bleibt bisher ungelöstes Kernproblem

*Codebase*

[github.com/lalex16/Schambot\\_UP](https://github.com/lalex16/Schambot_UP)



*Kontakt*

[laura.alex@uni-potsdam.de](mailto:laura.alex@uni-potsdam.de)

[jakob.fink-lamotte@uni-potsdam.de](mailto:jakob.fink-lamotte@uni-potsdam.de)

# Literaturverweise

Casu, M., Triscari, S., Battiato, S., Guarnera, L., & Caponnetto, P. (2024). AI Chatbots for Mental Health: A Scoping Review of Effectiveness, Feasibility, and Applications. *Applied Sciences*, 14(13), 5889.

<https://doi.org/10.3390/app14135889>

Dearing, R. L., & Tangney, J. P. (2011). *Shame in the therapy hour*. American Psychological Association.

Fink-Lamotte, J., Hoyer, J., Platter, P., Stierle, C., & Exner, C. (2023). Shame on Me? Love Me Tender! Inducing and Reducing Shame and Fear in Social Anxiety in an Analogous Sample. *Clinical Psychology in Europe*, 5(3), e7895.

<https://doi.org/10.32872/cpe.7895>

Kim, S., Thibodeau, R., & Jorgensen, R. S. (2011). Shame, guilt, and depressive symptoms: A meta-analytic review.

*Psychological Bulletin*, 137(1), 68–96. <https://doi.org/10.1037/a0021466>